



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 15 — Crise Hipertensiva: emergência hipertensiva, elevação importante da PA sem lesão de órgão-alvo e pseudocrise

Diferenciação em 3 categorias, metas de redução por órgão-alvo, fármacos IV disponíveis no Brasil, situações especiais (gestante, dissecção, AVC, EAP) e regulação — cenário: pronto-socorro sem UTI própria

Código	PS-ND-15	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A pressão arterial elevada é a queixa cardiovascular mais frequente do PS e a mais frequentemente **tratada de forma errada**: de um lado, o paciente assintomático que recebe captopril sublingual e sai com PA "normal" e retorno nenhum; de outro, a dissecção de aorta ou o edema agudo de pulmão que espera na fila porque "é só pressão alta". O que define a conduta **não é o número, é a presença de lesão aguda de órgão-alvo (LOA)**. A DBHA 2025 substituiu o termo "urgência hipertensiva" por "**elevação importante da PA sem LOA aguda**" justamente para retirar a conotação de emergência de uma condição que se trata por via oral e com retorno ambulatorial [DBHA 2025, Quadro 11.1].

Fontes de ancoragem: Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial - 2025 (SBC/SBH/SBN), capítulo 11 — Crise Hipertensiva (Arq Bras Cardiol 2025;122(9):e20250624; DOI 10.36660/abc.20250624) [DBHA 2025, Quadros 11.1-11.4]; Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial - 2020, capítulo 15 (Arq Bras Cardiol 2021;116(3):516) [DBHA 2020] para metas por órgão-alvo mantidas; AHA Scientific Statement — Management of elevated blood pressure in the acute care setting (Bress AP, et al. Hypertension 2024;81:e94) [AHA 2024]; 2023 ESH Guidelines (J Hypertens 2023;41:1874) e 2024 ESC Guidelines for elevated BP and hypertension (Eur Heart J 2024); Peixoto AJ. Acute severe hypertension. N Engl J Med 2019;381:1843; para situações específicas: Protocolos 01 (SCA), 03 (AVC), 09 (IC/EAP), 14 (eclâmpsia) desta série.

Convenção de confiança: doses IV trazem a fonte (Quadro 11.4 da DBHA 2025). Fármacos marcados com * no Quadro 11.4 (labetalol, nicardipina, enalaprilato, fenoldopam, fentolamina, trimetafano, diazóxido) **não estão disponíveis no Brasil** e foram omitidos das condutas. Itens **[VERIFICAR]**: nitroglicerina, esmolol, bomba de infusão, TC local.

1. Queixa — como o paciente chega

Três perfis muito diferentes chegam com "pressão alta":

Perfil	Como se apresenta	O que é, na maioria das vezes
A — "vim medir e estava alta"	Assintomático ou com cefaleia tensional, tontura inespecífica, ansiedade, dor (cólica, lombalgia), retenção urinária, "esqueci o remédio"; PA 180-220/110-130	Pseudocrise (PA elevada reativa a dor/ansiedade/desconforto) ou elevação importante sem LOA (hipertensão mal controlada). Não é emergência

Perfil	Como se apresenta	O que é, na maioria das vezes
B — "a pressão subiu e ele piorou"	Cefaleia intensa + vômitos + confusão/sonolência/convulsão/visão turva; ou dor torácica; ou dispnéia súbita/ortopneia; ou déficit focal; ou oligúria/hematúria; PA geralmente $\geq 180/120$, mas pode ser menor	Emergência hipertensiva — LOA aguda: encefalopatia, AVC, SCA, EAP, dissecação, LRA, hipertensão maligna
C — populações especiais	Gestante >20 semanas ou puérpera com PA $\geq 160/110$, cefaleia, epigastralgia, escotomas; usuário de cocaína/crack agitado, taquicárdico, sudoreico; suspensão abrupta de clonidina/betabloqueador; feocromocitoma (paroxismos de cefaleia + sudorese + palpitação)	Pré-eclâmpsia grave/eclâmpsia; crise adrenérgica; rebote

Perguntas-chave: há sintoma de órgão-alvo (cabeça, coração, pulmão, rim, olho)? A PA está assim há horas ou há anos mal controlada? Suspendeu medicação (qual, quando)? Usou cocaína/anfetamina/descongestionante/AINE/corticoide? Está grávida? Tem dor ou motivo para estar ansioso?

2. Clínica — as três categorias e as emergências por órgão

2.1 Definições operacionais [DBHA 2025, Quadro 11.1; AHA 2024]

Categoria	Critérios	Local / prazo	Tratamento
Emergência hipertensiva	PA acentuadamente elevada (em geral $\geq 180/120$, mas o critério é a LOA com lesão aguda e progressiva de órgão-alvo ; risco iminente de morte	Sala de emergência → UTI (transferir)	Parenteral, em bomba, com monitor; meta específica por órgão
Elevação importante da PA sem LOA aguda (ex-"urgência")	PA acentuadamente elevada ($\geq 180/120$), sem LOA aguda; pode haver sintomas inespecíficos	Observação no PS por algumas horas; acompanhamento ambulatorial precoce em 1-7 dias	Oral, combinações, redução gradual em 24-48 h; sem meta de "normalizar" no PS
Pseudocrise hipertensiva	PA elevada reativa a dor, ansiedade, síndrome do pânico, retenção urinária, hipóxia, abstinência, ou efeito do avental branco; sem LOA	Sala de espera/observação breve	Tratar a causa (analgesia, ansiolítico, sondagem); reavaliar PA em repouso 30-60 min; sem anti-hipertensivo de urgência

2.2 Emergências hipertensivas — como reconhecer cada uma [DBHA 2025, Quadros 11.2-11.3]

Emergência	Pistas clínicas	Confirmação
Encefalopatia hipertensiva	Cefaleia intensa, náusea/vômito, confusão, sonolência, convulsão, cegueira cortical; sem déficit focal fixo; papiledema; evolui em horas; melhora com a redução da PA (diagnóstico de exclusão)	TC de crânio normal ou edema posterior (PRES na RM); afastar AVC/HIC
AVC isquêmico / HIC / HSA	Déficit focal súbito; cefaleia thunderclap; rebaixamento	TC — Protocolo 03 (metas próprias: não baixar no AVCi <220/120 salvo trombólise; HIC PAS 140)
Síndrome coronariana aguda	Dor torácica típica, ECG isquêmico, troponina	Protocolo 01; nitroglicerina + betabloqueador
Edema agudo de pulmão hipertensivo	Dispneia súbita, ortopneia, estertores difusos, hipoxemia, PA muito alta, congestão ao RX/POCUS; FEVE muitas vezes preservada (EAP "flash")	Protocolo 09; nitrato em dose alta + VNI + furosemda
Dissecção aguda de aorta	Dor torácica/dorsal lacerante, migratória, máxima no início; assimetria de pulsos/PA >20 mmHg; sopro de IAO novo; síncope; déficit focal + dor torácica; mediastino alargado	Angio-TC de aorta (transferir para realizar); ECG geralmente sem supra — nunca antiagregar/anticoagular
Hipertensão acelerada/maligna	PA muito alta + retinopatia grau III/IV (hemorragias, exsudatos, papiledema) ± LRA, hematúria, anemia hemolítica microangiopática, IC	Fundo de olho, creatinina, urina I, hemograma com esquizócitos, LDH
Lesão renal aguda hipertensiva	Oligúria, hematúria, edema, elevação de creatinina	Creatinina/ureia, urina I, K, USG
Pré-eclâmpsia grave / eclâmpsia / HELLP	Gestante ≥20 sem ou puérpera: PA ≥160/110, cefaleia, escotomas, epigastralgia, convulsão; plaquetopenia, transaminases, hemólise	Proteinúria, plaquetas, TGO/TGP, LDH, creatinina — Protocolo 14 (MgSO ₄) + obstetrícia
Crise adrenérgica (cocaína, anfetamina, feocromocitoma, rebote de clonidina)	Agitação, taquicardia, sudorese, midríase, dor torácica; PA lábil	Toxicológico; ECG/troponina; metanefrinas (ambulatorial)

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / conduta
Técnica da medida	Manguito adequado ao braço, paciente sentado 5 min em repouso, sem dor, bexiga vazia, sem fala; 3 medidas, média das 2 últimas ; repetir em 30-60 min se sem LOA [DBHA 2025, cap. 3]. PA medida uma vez na triagem em paciente com dor não define nada
PA nos dois braços e pulsos dos 4 membros	Diferença >20 mmHg ou pulso ausente → dissecção; diferença MMSS-MMII → coarctação
Neurológico	Nível de consciência, déficit focal, campos visuais, rigidez de nuca, papiledema (fundo de olho é o exame mais negligenciado e mais útil na suspeita de emergência)
Cardiovascular	B3/B4, sopro diastólico aórtico (dissecção), estase jugular, estertores, edema, ritmo (FA)
Respiratório	FR, SpO ₂ , estertores bilaterais, sibilos (asma cardíaca), esforço
Abdome	Sopro abdominal (renovascular), massas, bexigoma (retenção urinária = pseudocrise), dor epigástrica (HELLP)
Pele / sinais de uso de drogas	Sudorese, midríase, agitação, marcas de punção
Gestação	Idade gestacional, edema, reflexos exaltados, clônus

4. Propedêutica armada [DBHA 2025, Quadro 11.3]

Pseudocrise e elevação sem LOA: na ausência de sintomas de órgão-alvo, exames são dispensáveis no PS (AHA 2024) — quando houver dúvida, ECG, creatinina, potássio e urina I bastam.
Suspeita de emergência: conjunto mínimo obrigatório abaixo.

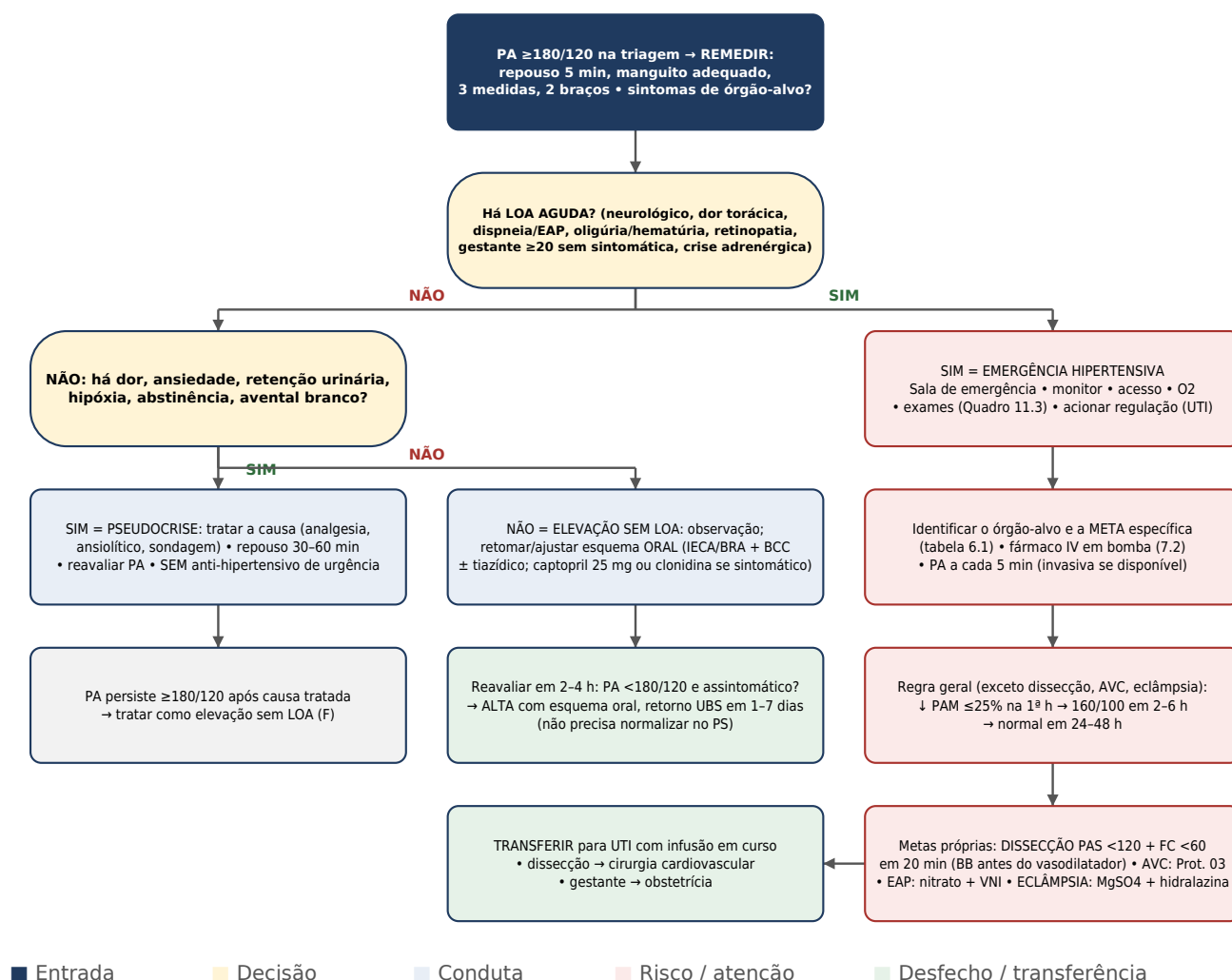
Exame	O que procurar	Quando
ECG	Isquemia, sobrecarga de VE, arritmia	Toda suspeita de emergência; dor torácica; dispneia
Creatinina, ureia, potássio, sódio	LRA, hipocalemia (hiperaldosteronismo), hipercalemia	Idem
Urina I	Hematúria dismórfica, proteinúria (maligna, glomerulonefrite, pré-eclâmpsia)	Idem
Hemograma + esquizócitos, LDH, bilirrubinas	Anemia hemolítica microangiopática (hipertensão maligna, HELLP, PTT)	Suspeita de maligna/gestante
Troponina, BNP/NT-proBNP	SCA, IC descompensada	Dor torácica, dispneia
Radiografia de tórax / POCUS	Congestão, mediastino alargado, derrame	Dispneia, dor torácica
TC de crânio	HIC, HSA, AVCi, edema (PRES)	Qualquer sintoma neurológico — se sem TC local, transferir
Angio-TC de aorta	Dissecção	Dor torácica/dorsal com pulsos assimétricos ou alta suspeita — transferir
Fundo de olho	Hemorragias, exsudatos, papiledema (KWB III/IV)	Suspeita de encefalopatia/maligna
β-hCG	Gestação	Toda mulher em idade fértil com PA elevada
Toxicológico (cocaína/anfetamina)	Crise adrenérgica	Agitação, jovem, taquicardia

5. Fisiopatologia

A elevação abrupta da PA além da capacidade de **autorregulação** dos leitos cerebral, renal e coronariano produz vasodilatação forçada, hiperperfusão, ruptura da barreira endotelial, edema vasogênico (encefalopatia, PRES) e necrose fibrinoide arteriolar (hipertensão maligna) — um ciclo em que a lesão vascular renal ativa o sistema renina-angiotensina e a natriurese pressórica gera hipovolemia relativa, elevando ainda mais a PA. No **hipertenso crônico**, a curva de autorregulação está deslocada para a direita: o cérebro tolera PA alta, mas **não tolera quedas rápidas** — reduzir >25% da PAM na primeira hora pode causar isquemia cerebral, renal e coronariana. Por isso a redução na emergência é **gradual e monitorada**, e no AVC isquêmico é permissiva. A **dissecção de aorta** é a exceção: a força de cisalhamento (dP/dt) propaga a lesão, e o alvo é PA e FC baixas em minutos, com betabloqueador **antes** do vasodilatador (o vasodilatador isolado aumenta o dP/dt reflexo). No **EAP hipertensivo**, a pós-carga aguda reduz o débito de um VE muitas vezes com função sistólica preservada — o nitrato em dose alta é o tratamento, não o diurético isolado. Na **crise adrenérgica**, o bloqueio β isolado deixa o α sem oposição e piora a vasoconstrição — usar benzodiazepínico e vasodilatador. A **pseudocrise** é resposta simpática fisiológica a dor, medo ou desconforto, e cede com o tratamento da causa.

6. Fluxo de atendimento [DBHA 2025, Figura 11.1, adaptado]

A primeira decisão é "**há lesão aguda de órgão-alvo?**" — não "quanto está a pressão?". A segunda é "há uma causa para a PA estar alta agora?". Só depois vem o fármaco.



6.1 Metas de redução da PA por situação [DBHA 2020, cap. 15; DBHA 2025; AHA 2024; Protocolos 01/03/09/14]

Situação	Meta	Fármaco de escolha (Brasil)
Regra geral (encefalopatia, maligna, LRA)	↓ PAM ≤20-25% na 1ª hora; 160/100-110 em 2-6 h; normal em 24-48 h. Se piora neurológica/renal durante a queda → parar e aceitar PA mais alta	Nitroprussiato (cautela na LRA e na PIC elevada); alternativa: nitroglicerina + metoprolol; hidralazina IV
Dissecção aguda de aorta	PAS 100-120 mmHg e FC ≤60 bpm em ≤20 min ; analgesia com opioide	Betabloqueador IV primeiro (esmolol ou metoprolol) e só depois nitroprussiato; nunca vasodilatador isolado; nunca antitrombótico
AVC isquêmico	Não tratar se ≤220/120 (sem trombólise); <185/110 antes de trombólise e <180/105 nas 24 h seguintes; reduzir ≤15% em 24 h	Metoprolol, esmolol, nitroprussiato (Protocolo 03)
Hemorragia intracerebral	PAS 140 (130-150) em ≤1 h, sem <130	Esmolol/metoprolol/nitroprussiato/hidralazina (Protocolo 03)
Hemorragia subaracnóidea	PAS <160 até tratar o aneurisma	Idem + nimodipina VO
SCA	PA <140/90 sem hipotensão; aliviar isquemia	Nitroglicerina IV + metoprolol (se sem contraindicação) (Protocolo 01)
EAP hipertensivo	↓ PAS 20-25% na 1ª h; alívio dos sintomas	Nitroglicerina IV em dose alta (ou nitroprussiato) + VNI + furosemida (Protocolo 09)
Pré-eclâmpsia grave / eclâmpsia (PA ≥160/110)	PA 140-155/90-105; nunca <130/80 (perfusão placentária); tratar em ≤30-60 min	Hidralazina 5 mg IV a cada 20 min (máx. 30 mg) ou nifedipino 10 mg VO a cada 20-30 min (máx. 50 mg) + MgSO ₄ (Protocolo 14); sem nitroprussiato (cianeto fetal), sem IECA/BRA
Crise adrenérgica (cocaína/anfetamina)	Controle da agitação e da PA	Benzodiazepínico (diazepam 10 mg IV, repetir) + nitroglicerina/nitroprussiato; evitar betabloqueador isolado
Feocromocitoma	Controle da PA	Nitroprussiato; betabloqueador só após bloqueio α (fentolamina indisponível)
Rebote por suspensão de clonidina	Controle gradual	Reintroduzir clonidina VO; nitroprussiato se grave
Elevação importante sem LOA	PA <180/120 em horas; meta ambulatorial (<130/80) em semanas	Oral: retomar esquema; captopril 25 mg VO (repetir em 1 h), clonidina 0,1-0,2 mg VO; iniciar/ajustar combinação

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Elevação importante sem LOA e pseudocrise — via oral, sem pressa [DBHA 2025; AHA 2024]

Conduta	Detalhe
Não fazer	Nifedipino sublingual/de liberação rápida (quedas abruptas → AVC/IAM; DBHA proíbe); captopril "sublingual" (não há absorção sublingual — é VO); furosemida IV em quem não está congesto; nitroprussiato para número; "zerar" a PA antes da alta
Pseudocrise	Tratar a causa: analgesia (dipirona/paracetamol ± opioide), ansiolítico (diazepam 5–10 mg VO se pânico), sondar bexigoma, O ₂ se hipóxia; repouso em ambiente calmo; remedir em 30–60 min
Hipertenso que abandonou o tratamento	Retomar o esquema prévio (ou reintroduzir combinação dupla: IECA/BRA + BCC ou + tiazídico) no PS; se muito sintomático (cefaleia intensa sem LOA): captopril 25 mg VO (início 15–30 min, repetir em 1 h se PA ≥180/120) ou clonidina 0,1-0,2 mg VO (início 30–60 min; sedação; evitar em rebaixamento) [DBHA 2025, Quadro 7.7]
Hipertenso sem diagnóstico prévio	Iniciar combinação dupla em dose baixa (ex.: losartana 50 mg + anlodipino 5 mg, ou enalapril 10 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg) [DBHA 2025, cap. 7]; gestante/idade fértil: nifedipino retard ou metildopa
Observação e alta	2–4 h; alta se PA <180/120 (ou queda ≥20–30 mmHg) e assintomático; receita, orientação de MRPA, retorno na UBS em 1-7 dias (agendar antes de sair); exames de rotina da HA na APS (creatinina, K, urina, lipídios, glicemia, ECG)

7.2 Emergência hipertensiva — fármacos IV disponíveis no Brasil [DBHA 2025, Quadro 11.4]

Fármaco	Dose / preparo	Início / duração	Indicação preferencial	Cautelas
Nitroprussiato de sódio	0,25-10 mcg/kg/min em bomba; 50 mg em 250 mL SG 5% (200 mcg/mL); 70 kg: 0,25 mcg/kg/min $\approx$ 5 mL/h; titular a cada 3-5 min	Imediato / 1-2 min	Maioria das emergências; encefalopatia, maligna, dissecação (após BB), EAP	Proteger da luz; intoxicação por cianeto/tiocianato (>48-72 h, DRC, hepatopatia, >2 mcg/kg/min prolongado); $\uparrow$ PIC; hipotensão brusca; gestante: evitar . PA invasiva ideal
Nitroglicerina	5-15 mg/h ($\approx$ 5-200 mcg/min); 50 mg em 250 mL SG 5% (200 mcg/mL); iniciar 3 mL/h (10 mcg/min), dobrar a cada 3-5 min	2-5 min / 3-5 min	SCA, EAP (dose alta: 100-200 mcg/min)	Cefaleia, taquicardia, taquifilaxia, hipotensão em IAM de VD; contraindicada com sildenafil/tadalafila; frasco/equipos de PVC adsorvem [VERIFICAR disponibilidade]
Metoprolol IV	5 mg IV lento (2-5 min), repetir a cada 10 min até 20 mg	5-10 min / 3-4 h	SCA, dissecação (com nitroprussiato), AVC pré-trombólise	Bradicardia, BAV, IC descompensada, asma/DPOC grave, cocaína (evitar isolado)
Esmolol	Ataque 500 mcg/kg em 1 min $\rightarrow$ 25-50 mcg/kg/min, $\uparrow$ 25 a cada 10-20 min, máx. 300 mcg/kg/min	1-2 min / 10-20 min	Dissecação (1ª escolha, titulável), pós-operatório, AVC	Hipotensão, BAV, broncoespasmo; caro/estoque [VERIFICAR]
Hidralazina IV	10-20 mg IV (gestante: 5 mg, repetir a cada 20 min, máx. 30 mg) ou 10-40 mg IM 6/6 h	10-30 min / 3-12 h	Eclâmpsia/pré-eclâmpsia grave ; alternativa sem bomba	Taquicardia reflexa, cefaleia, vômitos; piora angina/IAM; imprevisível (não titulável); cautela em PIC elevada
Furosemida IV	20-60 mg (repetir em 30 min)	2-5 min / 30-90 min	Só EAP/hipervolemia, LRA com congestão	Hipocalemia; na hipertensão maligna há hipovolemia relativa — diurético piora
Nifedipino VO (retard/ação longa) — não sublingual	10-20 mg VO (gestante: 10 mg a cada 20-30 min, máx. 50 mg)	20-30 min / 4-6 h	Gestante (alternativa/adjuvante à hidralazina)	Não associar a MgSO_4 em bólus rápido; cefaleia, taquicardia

Labetalol, nicardipina, clevidipina, enalaprilato, fenoldopam, fentolamina, trimetafano e diazóxido constam do Quadro 11.4 da DBHA 2025 com asterisco (**não disponíveis no Brasil**) e não fazem parte deste protocolo. Se o serviço adquirir algum, revisar a tabela.

7.3 Regras de segurança durante a infusão

- PA a cada 3–5 min na titulação, depois a cada 15 min; PA invasiva se nitroprussiato por >1 h ou instabilidade [VERIFICAR disponibilidade].
- Nunca reduzir >25% da PAM na 1ª hora (exceto dissecação); se aparecer confusão, déficit, oligúria ou dor torácica durante a queda: reduzir a infusão e aceitar PA mais alta.
- Iniciar anti-hipertensivo **oral** assim que a PA estiver na meta das primeiras horas, para permitir o desmame da infusão (IECA/BRA + BCC ± tiazídico; ou o esquema prévio).
- Hipertensão maligna com desidratação: repor volume com cautela antes/junto do vasodilatador; suspender diurético.
- Registrar no prontuário: LOA identificada, meta escolhida, fármaco/dose/hora, PA seriada e sintomas durante a redução.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
Toda emergência hipertensiva em infusão IV (nitroprussiato/nitroglicerina/esmolol)	Imediata (UTI em ≤6 h), com infusão em curso e monitor	UTI
Dissecação de aorta (suspeita forte ou confirmada)	Imediata, com BB + nitroprussiato em curso, analgesia, 2 acessos, tipagem	Cirurgia cardiovascular / hemodinâmica
AVC/HIC/HSA, SCA, EAP refratário	Imediata	Conforme Protocolos 03/01/09
Pré-eclâmpsia grave / eclâmpsia / HELLP	Imediata, com MgSO ₄ em curso	Obstetrícia com UTI
Hipertensão maligna com LRA/MAT, sem sintomas neurológicos	Mesmo dia	Enfermaria/UTI com nefrologia
Elevação sem LOA controlada	Alta com retorno em 1–7 dias na UBS	APS

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192: monitor, PA a cada 5 min, bomba de infusão com o vasodilatador em curso (nitroprussiato protegido da luz), O₂, acesso duplo.
- Relatório: PA de chegada (2 braços), LOA identificada, exames, meta definida, fármacos (dose/hora), PA seriada e resposta, sintomas neurológicos durante a redução, medicações de uso e adesão, drogas, gestação.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência com UTI: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica** (rede pactuada em 04/09/2026).

8.3 O que fica para a APS/UBS (contrarreferência obrigatória)

- Elevação sem LOA e pseudocrise: encaminhamento escrito para consulta em 1–7 dias com o esquema iniciado/ajustado, orientação de MRPA e lista de exames; o PS não é o lugar de titular anti-hipertensivo.
- Investigar causas secundárias na APS quando: <30 anos, hipocalcemia, HA resistente, sopro abdominal, paroxismos, AOS, crise em uso de ACO (DBHA 2025, Quadro 4.5).
- Notificar a equipe de Saúde da Família (ACS) sobre abandono de tratamento — o retorno ao PS por PA alta é falha de vínculo, não de fármaco.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de PA $\geq 180/120$ com remediação documentada após repouso (técnica) antes de qualquer conduta	$\geq 90\%$
% de pacientes com categoria registrada (emergência / elevação sem LOA / pseudocrise)	100%
% de uso de nifedipino sublingual ou vasodilatador IV em paciente sem LOA (evento sentinela)	0
% de emergências com meta pressórica escrita e PA seriada a cada ≤ 15 min	$\geq 90\%$
% de dissecação com betabloqueador antes do vasodilatador e sem antitrombótico	100%
% de altas por elevação sem LOA com retorno agendado na UBS em ≤ 7 dias	$\geq 90\%$
Retorno ao PS por PA elevada em 30 dias (mesmo paciente)	Registrar; tendência de queda

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Nomenclatura	DBHA 2025 substituiu "urgência hipertensiva" por "elevação importante da PA sem LOA aguda"; AHA 2024 abandonou "crise"/"urgência" para o paciente internado. Adotada a DBHA 2025; o termo "urgência" aparece só como sinônimo histórico
Limiar numérico	DBHA: $\geq 180/120$; ESH: $\geq 180/110$; AHA: $> 180/120$. Todas concordam que o critério de emergência é a LOA, não o número. Adotado $\geq 180/120$ como gatilho de atenção
Velocidade de redução geral	DBHA 2020: $\leq 25\%$ na 1ª h $\rightarrow 160/100$ em 2-6 h $\rightarrow$ normal em 24-48 h; ESC 2024 semelhante; AHA 2024 enfatiza órgão-específico. Adotada a regra da DBHA com exceções explícitas
Dose de nitroprussiato	O material de slides da DBHA 2025 traz "mg/kg/min" (erro tipográfico); a unidade correta é mcg/kg/min (Quadro 11.4 do texto integral e bula). Adotado 0,25-10 mcg/kg/min
Fármacos indisponíveis	Labetalol/nicardipina são 1ª linha em diretrizes internacionais e não existem no Brasil — o protocolo usa metoprolol/esmolol e nitroprussiato/nitroglicerina. Estoque de esmolol e nitroglicerina [VERIFICAR]
Tratamento da elevação sem LOA	Evidência de benefício de tratar no PS é fraca (AHA 2024: sem benefício, potencial dano); DBHA mantém tratamento oral com retorno em 1-7 dias. Adotado: oral, gradual, sem meta de normalização
Gestante	Hidralazina e nifedipino VO são as opções nacionais (labetalol indisponível); metas de PA da FEBRASGO/DBHA cap. 10. Confirmar estoque de $MgSO_4$ e gluconato de cálcio [VERIFICAR]
PA invasiva e TC local	Definem se a emergência pode ser conduzida por horas no PS [VERIFICAR]

10. Referências

- Brandão AA, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Nadruz W, et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – 2025. Arq Bras Cardiol 2025;122(9):e20250624. DOI 10.36660/abc.20250624 — capítulo 11 (Crise Hipertensiva), Quadros 11.1–11.4; capítulos 3, 7 e 10.
- Barroso WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol 2021;116(3):516-658 — capítulo 15.
- Bress AP, Anderson TS, Flack JM, et al. The management of elevated blood pressure in the acute care setting: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension 2024;81(8):e94-e106.
- McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J 2024;45(38):3912-4018. Mancía G, et al. 2023 ESH Guidelines. J Hypertens 2023;41(12):1874-2071.
- Peixoto AJ. Acute severe hypertension. N Engl J Med 2019;381(19):1843-1852.
- Isselbacher EM, Preventza O, Black JH, et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the diagnosis and management of aortic disease. Circulation 2022;146:e334-e482 (metas na dissecação).
- FEBRASGO. Pré-eclâmpsia nos seus diversos aspectos. Série Orientações e Recomendações, 2023; Ministério da Saúde. Manual de gestação de alto risco, 2022.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática* — HC-FMUSP. Manole, edição vigente — capítulo de emergências hipertensivas (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração